

Asciminib : Nouvelle thérapie ciblée dans la leucémie myéloïde chronique

Revue de la littérature

F. MEZHOUD¹, Z. OUCHENANE¹.
¹Service Hématologie CHU Constantine

Introduction

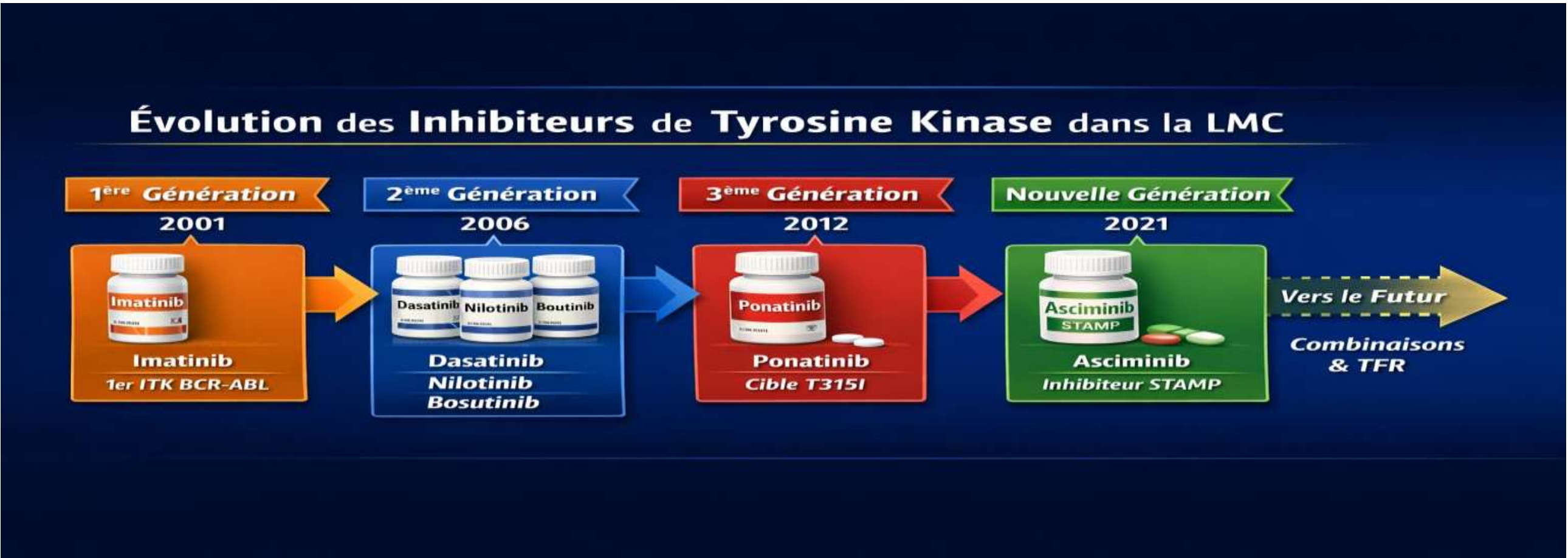
Les inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) ont révolutionné la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique (LMC), transformant son pronostic. Toutefois, la survenue de résistances ou d'intolérances aux ITK conventionnels demeure un défi thérapeutique, justifiant le développement de nouvelles stratégies ciblées. L'asciminib, premier inhibiteur STAMP (*Specifically Targeting the ABL Myristoyl Pocket*), représente une innovation majeure grâce à son mécanisme d'action original

Méthodes

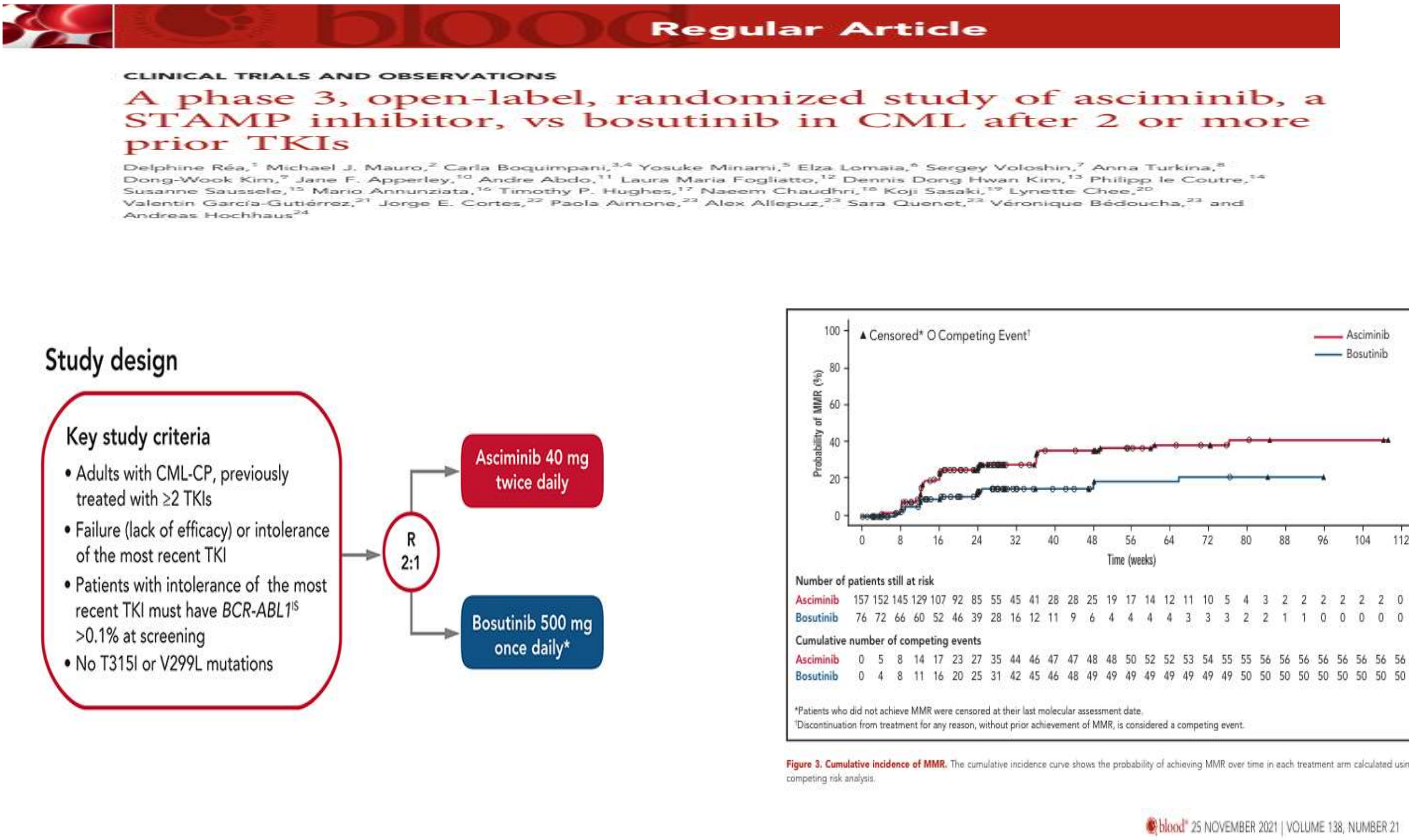
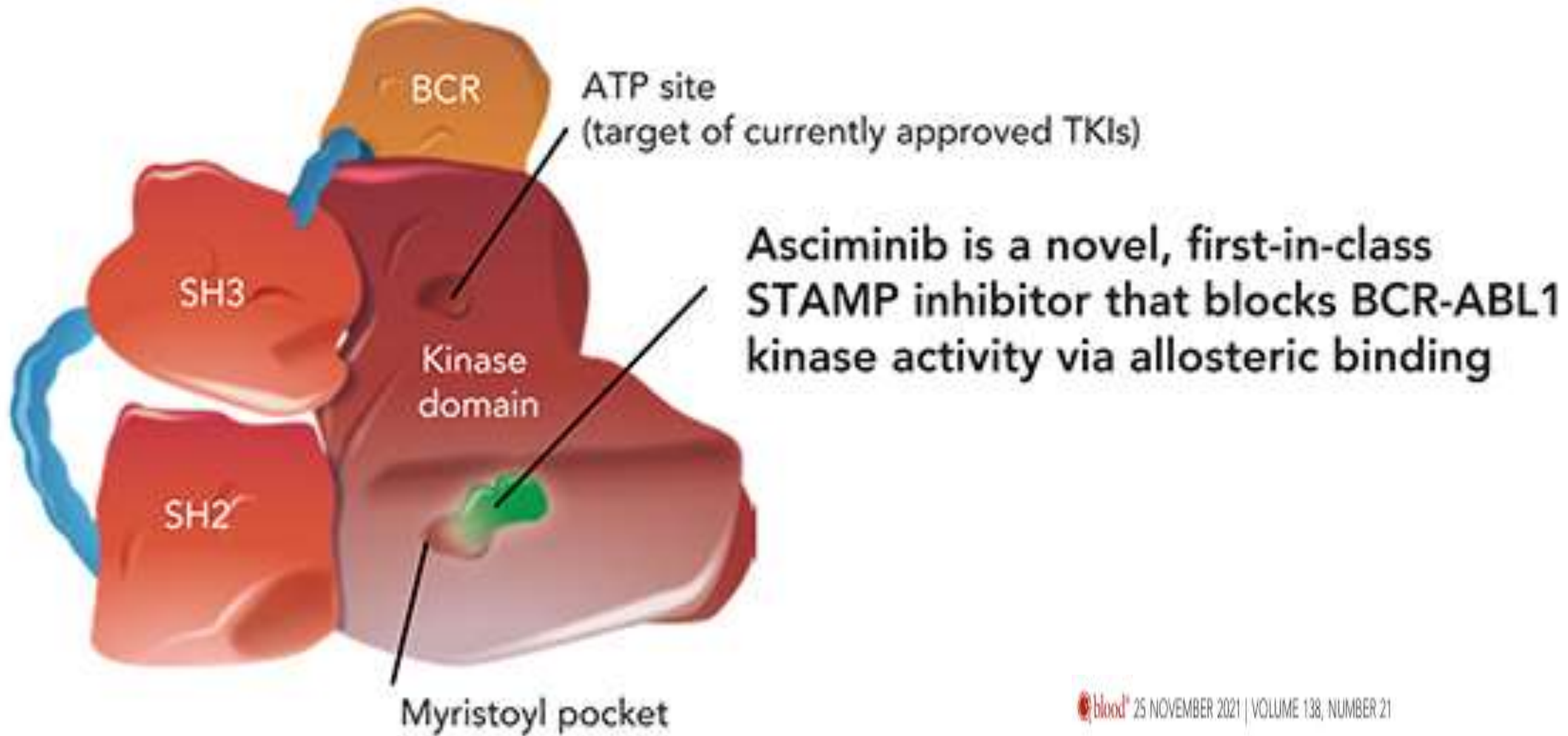
Une revue de la littérature récente a été réalisée à partir des principaux essais cliniques portant sur l'asciminib dans la LMC en phase chronique.

Résultats

- ❑ Contrairement aux ITK conventionnels ciblant le site de liaison à l'ATP de BCR::ABL1, l'asciminib agit en se fixant spécifiquement sur la poche myristoyle de la protéine ABL1, permettant une inhibition allostérique de BCR::ABL1 et un contournement de certains mécanismes de résistance.
- ❑ Son autorisation initiale repose sur l'étude pivot **ASCEMBL**, essai de phase III, randomisé, ouvert, comparant l'asciminib au bosutinib chez des patients atteints de LMC en phase chronique, prétraités par au moins deux ITK et en situation d'échec thérapeutique ou d'intolérance. Cette étude a montré une supériorité significative de l'asciminib en termes de réponse moléculaire majeure (RMM), avec un meilleur profil de tolérance.



Asciminib MOA



- ❑ Par ailleurs, les résultats de l'analyse primaire de l'essai de phase III **ASC4FIRST**, évaluant l'asciminib en première ligne, montrent des taux de RMM supérieurs à ceux obtenus avec les ITK standards, associés à une meilleure tolérance, confortant son potentiel comme futur traitement de première intention.

L'analyse finale de cette étude est attendue en 2028.

Conclusion

L'asciminib constitue une option thérapeutique innovante et efficace dans la LMC. Sa disponibilité en Algérie apparaît comme un enjeu majeur pour améliorer la prise en charge des patients en échec ou intolérants aux ITK, notamment après plusieurs lignes de traitement.

